Bảng 2.Tỉ lệ phần trăm các đối tượng có nồng độ kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn ≥0,35 µg/ml 1 tháng sau đợt tiêm chủng dành cho trẻ sơ sinh

Týp huyết thanh	2, 3, 4 tháng Đức (6096A1-006)	2, 3, 4 tháng Ba Lan (6096A1-3000 Sản xuất)	2, 4, 6 tháng Tây Ban Nha (6096A1-501)	2, 4, 6 tháng Mỹ (6096A1-004)	2, 4, 6 tháng Mỹ Lô 1 (6096A1-3005)	2, 4, 6 tháng Mỹ Lô 2 (6096A1-3005)	2, 4, 6 tháng Mỹ Lô 3 (6096A1-3005)	2, 4, 6 tháng Canada (6096A1-3008)
	N=282-285	N=106-128	N=261-273	N=249-252	N=387-399	N=398-413	N=387-404	N=272-277
1	96,1	93,0	99,3	95,6	98,5	97,8	97,0	95,7
3	98,2	93,7	90,3	63,5	79,1	68,5	72,4	79,6
4	98,2	97,7	98,9	94,4	98,5	97,6	95,5	97,1
5	93,0	90,6	97,3	89,7	94,4	94,2	90,3	87,0
6A	91,9	85,2	97,4	96,0	98,2	98,1	95,5	96,4
6B	77,5	77,3	98,5	87,3	94,4	94,9	89,5	93,1
7F	98,6	100,0	100,0	98,4	99,7	99,8	99,0	98,6
9V	98,6	98,4	99,3	90,5	96,5	95,4	95,5	95,3
14	98,9	92,9	97,4	97,6	98,2	99,2	99,0	98,2
18C	97,2	96,1	98,1	96,8	98,0	97,8	95,8	96,4
19A	99,3	99,2	99,6	98,4	98,7	98,1	99,0	97,8
19F	95,8	98,4	99,3	98,0	99,2	97,8	97,5	98,5
23F	88,7	82,8	94,6	90,5	87,2	91,2	88,1	90,2

Ở trẻ tiêm Prevenar 13, kháng thể IgG liên kết kháng polysaccharid đối với mỗi týp trong 13 týp huyết thanh được cho thấy là có mối tương quan với hoạt tính thực bào opsonin hoá (OPA) kháng khuẩn (một kháng thể có hoạt tính sinh học). Các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy rằng đáp ứng với Prevenar 13 không thua kém đáp ứng với vắc xin cộng hợp 7 dòng đối với tất cả 13 týp huyết thanh khi xét trên các tiêu chuẩn về tính không thua kém miễn dịch đã định nghĩa trước. Các đáp ứng miễn dịch do Prevenar 13 tạo được đối với 6 týp huyết thanh thêm vào theo định lượng là cao hơn cho cả kháng thể liên kết với polysaccharid và kháng thể opsonin hoá so với các đáp ứng do vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn tạo ra.

Đáp ứng miễn dịch sau đợt tiêm chủng cơ bản gồm 2 liều

Tính sinh miễn dịch sau 2 liều ở trẻ sơ sinh đã được xác định trong 4 nghiên cứu. Tỉ lệ trẻ sơ sinh đạt nồng độ kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn ≥ 0,35 µg/ml 1 tháng sau liều thứ hai là từ 79,6% đến 98,5% cho 11 trong 13 týp huyết thanh trong vắc xin. Tỉ lệ đạt được nồng độ kháng thể này nhỏ hơn cho týp huyết thanh 6B (27,9% đến 58,4%) và 23F (55,8% đến 68,6%). So với đợt tiêm chủng 3 liều dành cho trẻ sơ sinh, nồng độ trung bình nhân của kháng thể IgG kháng polysaccharid vỏ phế cầu khuẩn thấp hơn sau đợt tiêm chủng 2 liều đối với đa số các týp huyết thanh. Tính hiệu quả lâm sàng của đợt tiêm chủng cơ bản gồm 2 liều đối với bệnh viêm tai giữa cấp tính hay viêm phổi chưa được xác định.